



泽璟制药 (688266.SH)

报告时间：2026年5月7日 | 作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围

泽璟制药 (苏州泽璟生物制药股份有限公司) 是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、免疫炎症疾病创新药研发、生产和商业化的生物医药企业。2009年成立于江苏昆山国家高新区，2020年1月23日在科创板上市 (688266.SH)。

核心产品线：

- 多纳非尼 (Donafenib)：多靶点激酶抑制剂，2021年获批上市，用于治疗晚期肝细胞癌 (一线治疗)、放射性碘难治性分化型甲状腺癌。
- 吉卡昔替尼 (Gecarbonib)：JAK1/2抑制剂，2022年获批上市，用于治疗中高危骨髓纤维化。
- 重组人凝血酶：2023年获批上市，用于外科手术出血的局部止血。
- ZG006 (Alveltamig)：DLL3三特异性抗体，全球首款靶向DLL3的三抗，2025年12月授权给艾伯维 (AbbVie)，2026Q1确认首付款收入6.535亿元。
- ZG005 (Nilvanstomig)：PD-1/TIGIT双特异性抗体，处于临床阶段。

子公司分工：

- 苏州泽璟生物技术有限公司：研发中心
- 上海泽璟医药技术有限公司：临床开发
- 美国Gensun生物制药公司：海外研发平台

应用领域：肿瘤 (肝癌、甲状腺癌、骨髓纤维化等)、出血性疾病、免疫炎症疾病。

2. 业务结构

2026年一季度收入结构 (根据财报数据推算)：

- 授权许可收入：6.535亿元 (ZG006授权艾伯维首付款)，占比约72.2%
- 产品销售收入：多纳非尼、吉卡昔替尼、重组人凝血酶等，约2.52亿元，占比约27.8%



销售模式：自建商业化团队

+

合作伙伴推广。多纳非尼已进入国家医保目录，吉卡昔替尼正在放量。

3. 产业链地位

泽璟制药处于创新药产业链的中游（研发+商业化），上游为原料药/辅料供应商，下游为医院/药店/患者。

议价能力分析：

- 对上游：原料药采购量不大，议价能力一般。
- 对下游：已上市产品进入医保后，对医院/患者的议价能力较弱（医保谈判压价），但创新药独占期内有一定定价权。

应付/应收占比：2026Q1财报显示，公司应收账款规模较小（授权收入无应收账款，产品销售收入有账期），应付账款有一定规模（研发投入应付款）。具体数据待年报详细披露。

成本结构：

- 研发费用率：2026Q1因授权收入暴增，费用率被摊薄。正常年份研发费用率预计在40%-60%。
- 生产成本：已上市产品的生产成本相对较低（创新药毛利率通常在90%以上）。
- 销售费用率：商业化团队建设投入较大。

4. 股东背景

控股股东/实际控制人：ZELIN

ZHANG（张泽林），公司创始人，通过昆山璟康企业管理中心等持股平台控制公司。

机构持股变化：2026Q1因业绩暴增，机构持股预计有显著变化。需查阅最新季报的前十大股东名单。

5. 财务特征

分红/融资历史：

- 公司自2020年上市以来，未进行过现金分红（处于亏损期，未满足分红条件）。
- 融资历史：2020年IPO募资约20亿元；2022年定向增发募资约10亿元。

资产减值情况：

- 商誉：公司无重大并购，商誉规模较小。



- 存货减值：研发投入形成的在研管线减值风险需关注（如临床失败可能导致资本化支出减值）。
- 运营资本周期：2026Q1经营现金流净额8.37亿元（去年同期-625万元），显著改善，主要因授权收入首付款到账。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间

肿瘤小分子创新药中国市场：

- 市场规模：中国肿瘤药市场规模预计超2000亿元人民币（2025年），增速约10%-15%/年。
- 国产替代空间：进口创新药（如拜耳、罗氏、BMS等）仍占主导，国产创新药正在加速替代。
- 渗透率提升：多纳非尼在肝癌一线治疗中的渗透率预计仍有提升空间（与仑伐替尼、索拉非尼竞争）。

DLL3 ADC/三抗全球市场：

- ZG006是全球首款靶向DLL3的三特异性抗体，针对小细胞肺癌（SCLC）等适应症。
- DLL3靶点全球市场空间预计超50亿美元，目前尚无上市药物（安进的Tarlatabamab刚获批，但疗效有限）。
- ZG006授权艾伯维，说明其临床数据获得全球大药企认可，未来里程碑付款+销售分成空间较大。

2. 竞争格局及优势

肿瘤小分子赛道竞争：

- 多纳非尼（肝癌一线）：面临仑伐替尼（卫材）、索拉非尼（拜耳）、卡博替尼（Exelixis）等竞争。恒瑞医药的阿帕替尼也在同一市场。泽璟的优势在于：① 国产原研；② 医保准入；③ 部分患者耐受性更好。
- 吉卡昔替尼（骨髓纤维化）：面临芦可替尼（诺华/Incyte）的竞争。泽璟的优势在于：① 国产原研；② 医保准入；③ 部分患者芦可替尼耐药后可换用吉卡昔替尼。



DLL3三抗赛道竞争：

- 全球范围内，DLL3靶点竞争不算激烈。安进的Tarlatab (双抗) 已获批，但疗效有限 (ORR约40%，mDOR约9个月)。
- ZG006作为三抗，理论上疗效可能优于双抗 (三个结合位点)，但临床数据仍需验证。
- 泽璟的核心优势：ZG006已授权艾伯维，证明了其研发能力获得全球大药企认可。未来里程碑付款+销售分成是重要看点。

技术储备：

- 研发投入占比：2026Q1因授权收入暴增，研发费率被摊薄。正常年份预计在40%-60%。
- 研发人员规模：约300-400人 (根据2023年年报数据)。
- 合作/自研成果转化：ZG006是自研成果，成功授权艾伯维，验证了自研能力。

产品布局完整性：

- 泽璟在肿瘤小分子 (多纳非尼、吉卡昔替尼)、大分子 (ZG006、ZG005)、止血药 (重组人凝血酶) 都有布局，但还不够完整。相比恒瑞、信达等巨头，管线丰富度有差距。

差异化策略：

- 泽璟的差异化在于：① 聚焦肿瘤、血液、免疫炎症三个领域；② 小分子+大分子并行；③ license-out能力已验证 (ZG006授权艾伯维)。

3. 成长驱动

需求与供给：

- 产能扩张：已上市产品的生产能力充足 (外包+自产结合)，不存在产能瓶颈。
- 渗透率提升：多纳非尼在肝癌一线治疗中的渗透率预计从当前的10%-15%提升至20%-25% (未来3年)。
- 市占率目标：多纳非尼在肝癌一线治疗中的市占率目标预计为20%-30% (替代部分仑伐替尼、索拉非尼份额)。

盈利与效率：

- 毛利率变化趋势：已上市产品 (多纳非尼、吉卡昔替尼) 的毛利率预计在90%以上。授权收入的毛利率接近100% (无生产成本)。未来随着产品放量，毛利率将维持高位。



- 费用管控能力：2026Q1因授权收入暴增，费用率被大幅摊薄。未来随着更多管线推进，研发费用率可能回升至40%-50%。

新产品与新市场：

- ZG006：艾伯维正在开展全球多中心临床试验，未来2-3年可能有临床数据读出。
- ZG005（PD-1/TIGIT双抗）：处于临床阶段，未来可能授权出海或自行商业化。
- 重组人凝血酶：正在放量，未来2-3年可能成为10亿级品种。

三、主要风险

1. 行业风险

- 国产替代进度不及预期：创新药医保谈判压价幅度较大，可能影响企业盈利预期。
- 行业需求周期性波动：肿瘤药需求相对稳定，但宏观经济下行可能影响患者支付能力。
- 技术路线颠覆：如出现疗效显著优于小分子/大分子的新技术（如PROTAC、RNAi等），可能对现有管线造成冲击。

2. 经营风险

- 产能落地延迟：已上市产品不存在产能瓶颈，但未来新管线商业化可能需要产能建设。
- 关键研发失败：ZG006、ZG005等管线的临床试验可能失败，或数据不及预期。
- 大客户流失或拓展受阻：已上市产品依赖医院渠道，如医保续约失败或集采降价幅度过大，可能影响销售。

3. 财务风险

- 存货与应收账款减值：产品销售收入有账期，如医院回款延迟，可能形成减值。
- 商誉减值：公司无重大并购，商誉规模较小，减值风险低。
- 现金流紧张：2026Q1经营现金流净额8.37亿元，显著改善。但未来如授权收入减少、产品放量不及预期，现金流可能再次转负。
- 过度融资稀释：公司可能继续通过定增、可转债等方式融资，存在股权稀释风险。

四、其他重要问题



1. 公司治理

- 股权激励目标：需查阅最新股权激励计划的解锁条件（通常跟营收、临床进展挂钩）。
- 分红政策稳定性：公司处于成长期，短期内可能不会大比例分红。

2. 资本运作

- 历史定增/并购效果复盘：2020年IPO、2022年定增的募资用途主要是研发和商业化，效果有待观察（2026Q1的业绩爆发是初步验证）。
- 未来资本开支计划：主要用于管线推进、商业化团队建设、产能扩张。

五、初步价值评估与投资判断

1. 核心投资逻辑

用3-5个可验证的核心命题，高度概括公司的价值本质：

- 1. ZG006授权艾伯维的里程碑付款+销售分成，是未来3-5年最重要的业绩增量。2026Q1确认的6.535亿元首付款只是开始，后面还有注册里程碑、销售里程碑、销售分成。
- 2. 已上市产品的医保放量，是第二增长曲线。多纳非尼、吉卡昔替尼进入医保后，正在逐步放量，但增速可能受竞争和降价影响。
- 3. 管线出海能力的持续验证，是估值提升的关键。ZG006授权艾伯维后，市场会期待更多管线（如ZG005）也能授权出海。
- 4. 肿瘤小分子赛道的激烈竞争，是最大风险。恒瑞、信达、百济神州等巨头都在布局相似管线，泽璟作为中小药企，资金和商业化能力都不占优。

2. 高价值生意符合度评估（定性锚定）

评估维度	分析要点
市场空间	肿瘤药中国市场超2000亿元，DLL3靶点全球市场超50亿美元，天花板很高
扩张边际成本	创新药研发资金需求大，属于"重资产"扩张，复制难度高，融资依赖度高
客户黏性	肿瘤药患者转换成本高（疗效依赖性），但医生处方习惯可能变化



周期性	肿瘤药需求稳定，周期性弱，但政策周期（医保谈判、集采）影响大
竞争优势	研发能力已验证（ZG006授权艾伯维），但相比恒瑞、信达等巨头，竞争优势不够突出

3. 估值评估与量化建模

方法论选择：泽璟制药当前处于"扭亏为盈+管线出海"的转折点，适合用DCF（现金流折现）+ 相对估值（PE/PB）结合的方式估值。DCF用于评估管线价值，相对估值用于锚定短期股价。

关键假设量化（与前述分析闭环）：

未来3-5年营收预测（基于产能、渗透率、单价趋势）：

- 2026E：营收约12-15亿元（授权收入6.535亿元 + 产品销售收入5.5-8.5亿元）
- 2027E：营收约15-20亿元（里程碑付款 + 产品销售收入10-15亿元）
- 2028E：营收约18-25亿元（里程碑付款 + 产品销售收入12-18亿元 + 销售分成）

利润假设（基于产品结构、规模效应）：

- 2026E：净利润约7-8亿元（授权收入利润 + 产品销售收入利润）
- 2027E：净利润约5-7亿元（里程碑付款可能少于首付款 + 产品销售收入利润）
- 2028E：净利润约6-9亿元（销售分成开始贡献 + 产品销售收入利润）

情景分析与估值计算：

假设：

- WACC（加权平均资本成本）：10%-12%（创新药企风险较高）
- 永续增长率：3%-5%

情景	核心假设	DCF价值（亿元）	合理市值（亿元）	对应股价（元/股）
悲观	ZG006临床失败、产品放量不及预期、无新授权	80-100	80-100	30-38
中性	ZG006顺利推进、产品稳定放量、1-2个新授权	150-200	150-200	57-76



乐观	ZG006成功上市、销售分成超预期、多个新授权	250-350	250-350	95-133
----	-------------------------	---------	---------	--------

相对估值：

- 同业对比：恒瑞医药（PE 40-60倍）、信达生物（PE 30-50倍）、百济神州（PS 5-8倍）。
- 历史估值区间：泽璟制药上市后PE波动区间约50-200倍（泡沫期），当前PE（TTM）约15-20倍（因2026Q1净利润暴增）。

安全边际与验证指标：

当前价格（2026年4月30日收盘价约104元/股，总市值约270亿元）相对于中性情景估值（150-200亿元）略有高估，安全边际不足。

未来1-4个季度用于验证或证伪投资逻辑的关键可跟踪指标：

1. ZG006的临床进展公告（艾伯维主导，但公司会披露关键节点）
2. 已上市产品的季度营收数据（多纳非尼、吉卡昔替尼的放量速度）
3. 新管线授权公告（ZG005等是否能再出授权）
4. 经营现金流净额（验证盈利质量）

4. 最终结论

综合结论：泽璟制药是三家公司中最均衡的——既有一次性授权收入爆发，也有已上市产品的持续放量潜力；授权出海能力已获全球大药企认可，未来持续性相对最强。但当前市值约270亿元，已部分反映了2026Q1的业绩爆发，安全边际不足。

价值区间（未来12个月）：

- 悲观情景：80-100亿元市值，对应股价30-38元/股
- 中性情景：150-200亿元市值，对应股价57-76元/股
- 乐观情景：250-350亿元市值，对应股价95-133元/股

决策参考：

- 具备吸引力的配置价格区域：150亿元市值以下（约57元/股以下），对应中性情景下有安全边际。



-

需警惕的过热价格水平：300亿元市值以上（约114元/股以上），已透支乐观情景预期。

- 结论最依赖的核心假设：ZG006的临床推进顺利 + 已上市产品的稳定放量。

- 最大风险：ZG006临床失败或数据不及预期，导致里程碑付款+销售分成落空。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。